



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : كريمة محمود ابراهيم عليان

العنوان : ش الشهداء-المينا-أول
الغردقة-البحر الاحمر

الحي / المدينة : الغردقه

المحافظة : البحر الاحمر

تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

رقم التليفون : 01009957988

رقم البطاقة : 26911243100144

العمر(تاريخ الميلاد) : 24-11-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كريمة محمود ابراهيم عليان National ID: 26911243100144	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

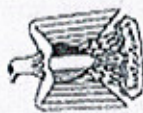
جمهورية مصر العربية
بطاقة هوية شخصية

كريمة
محمود إبراهيم عتيان
ش. الشهداء، الميناء -
أول العريقة - البحر الأحمر

٢٦٩١١٢٤٣١٠٠١٤٤

٩٩١٩٩٩

KL4365836



٢٠٢٤/٠٣ ٢٠١٩١١١٣١٠٠١٤٤
رؤية منزل

مستلمة
جناب محمد احمد موسى
مقروحة
٢٠٢١/٠٣/١٥ حتى ١٤



Name: كريمه محمود ابراهيم		
MR. : 4981		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيه طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
ER8/8&PR 6/8+HER2 -VE 8/2022 MDT :ADJUVANT :PORTH +AI 10/2025:SM.....FREE 10/2025:CTFREE 21/1/2026:FEMARA		
ER8/8&PR 6/8+HER2 -VE 8/2022 MDT :ADJUVANT :PORTH +AI 10/2025:SM.....FREE 10/2025:CTFREE 21/1/2026:FEMARA FEMARA CALCIUM ONE ALPHA		
The patient has completed the planned adjuvant therapy with PORT and AI, with imaging and surgical follow-up as scheduled, and is currently receiving FEMARA and FEMARA CALCIUM ONE ALPHA.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	نهى سعيد علي محمد
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

MDT FORM

23/8/2022

010990791
0279/000

Name	كريمة محمد علي	MRN	2218/2022
Age	52 Years	ID	5791/2421/1/22
Menopausal status		Phone	
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx: IDC grade II

ER: 8/8 PR: 6/8 HER2: 4.1 Ki67: 20

Sonomammography: CESM → Unicentric Mass

Mets Workup: CTs → Free Bone SA → Free

Recommendations:

- Case of Rt Breast Cancer
- Post Rt WLE, Extra inferior margins, S & B
- Free surgical margins.
- LN 2/20
- Partial pathological response -

MDT OUTCOME & PLAN

for PORT
for mod H. femora

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	
		RADIOLOGY	PATHOLOGY

25/8/2022

Amr shah
23/8/2022

Dr. ommy yong
23/08/2022

Patient Name	: الأستاذة / كريمه محمود ابراهيم عليان	Request No.	: 137090
Patient No.	: 26911243100144	Request Date	: 17/11/2021
Path No.	: 2806/21	Verification Date	: 21/11/2021
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast mass

Nature of the specimen:

Tru-Cut biopsy

Gross Examination:

4 greyish white and hemorrhagic tissue cores up to 1cm. Totally submitted.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma grade II
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: N/A
- Resection Margins: N/A
- Histologic response to therapy: N/A

Diagnosis:

Right breast mass; Tru-Cut biopsy:

Invasive duct carcinoma grade II

For IHC (ER, PR, Her-2, Ki67)

Prof. Dr Amal Hareedy

Dr. Abdulrahman Ibrahim



Women's Health Outreach Program

Name: Karima Mahmoud Ibrahim

Date: 04.01.2022

Contrast Enhanced Full field Digital Mammography

Clinical summary: RT breast CA

Technique

Pre and post contrast MLO and CC views

Detailed Findings:

Moderate Bilateral Background Uptake

Left breast:

- Scattered fibroglandular pattern, (ACR B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Contrast enhanced images showed:** no pathological contrast uptake.
- Normal skin/nipple/areolar complex.

Right breast:

- Scattered fibroglandular pattern, (ACR B).
- An irregular shaped mass is seen at the retroareolar region, located 4cm from the nipple; measuring 7.7 x 7 x 6.5cm in diameter.
- **Contrast enhanced images showed:** its intense heterogenous contrast uptake.
- Normal skin/nipple/areolar complex.

Conclusion:

Left breast: (BIRADS 1) normal study.

Right breast: (BIRADS 6= Pathology proved malignant) Single retroareolar malignant mass.

Best regards,
Dr Norran Hussein, MD FRCR



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m6080

Female :	النوع	كريمه محمود ابراهيم	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان	51 Y	السن :
29/11/2021 12:34 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة :
05/12/2021 09:59 :	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	طالب التحليل :
		مركز اورام دار السلام	عناية :

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of 80 % of tumour cells

PR: moderate nuclear staining of 60 % of tumour cells

HER2/neu protein over expression : discontinuous membrane staining of tumor cells.

Ki67 : positive nuclear staining of 20 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)

PR: POSITIVE (SCORE 6/8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (SCORE +1)

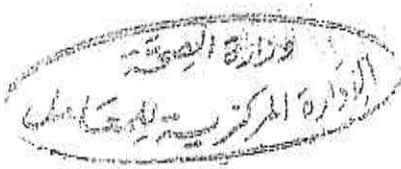
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 20 %

(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/ايمن رمزي

Lab Director: د/تريزا ماهر



٥٢٧٩
٥



Name : Karima Mahmoud Ibrahim

Date : 13-12-2021

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Right breast outer quadrant Irregular mass lesion reaching the nipple and skin which appear thickened and it shows central cystic degeneration measuring 6.5 X 4 cm.
- Right axillary level I multiple pathologically enlarged lymph nodes the largest measures 3.2 X 2.2 cm.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calcular gall bladder.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Few millimetric recto sigmoid mucosal polyps are seen.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus.
- Normal appearance of the other pelvic organs.

NUCLEAR MEDICINE UNIT



معهد ناصر
مركز الأورام
وحدة الطب النووي

Date: 4/6/2022

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes at the spine.
- Arthritic changes at knees and shoulders.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are seen.

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Shereen Mahdy, M.D

Huda Fathy, M.D.